



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : جيهان محمود عبد اللطيف عبد المجيد

الحي / المدينة : العاشر من

المحافظة : الشرقيه

رمضان

العنوان : ممم

تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

رقم البطاقة : 27606110103007 رقم التليفون : 01012812521

العمر(تاريخ الميلاد) : 11-06-1976 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الاورام

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر بالصبغه [11127]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: جيهان محمود عبد اللطيف عبد المجيد National ID: 27606110103007	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



menna Ahmed
Dms
تدعى
محمود عبد المنعم







٢٠١٩/٠٣ ٢٧٦.٦١١.١٠٣.٠٠٧

حاصلته على بكالوريوس تجاره

انثى مسلمة متزوجة

ماهر ابو الفتوح محمد حسن

البطاقة مارية حتى ٢٠٢١/٠٣/٣٠



٨





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
مبنى

MDT FORM

8/20/22

11/17/22

Name	جيه محمد عبداللطيف	MRN	0508
Age	40 y	ID	C.C.I
Menopausal status		Phone	01012812529
OCP		marital status	متزوج
Co morbidity		Family history	متزوج

Clinical Data

Bx:	IDC	Grade II	R	L			
ER:	8/8	PR:	5/8	HER 2:	+ve	Ki67:	35%
Sonomammography:							
Mets Workup:	no CT/MRI/M2, no						
Recommendations:	post NACT, post Lt MRM complete pathological response L.Ns 0/10 ypT yp.No						

MDT OUTCOME & PLAN

in view of PCR

→ To continue therapy + regular Rx

→ PORT

→ Hc - CIII (Adenocarcinoma - epithelial)

13-8-2022

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6300

Female :	النوع	جيهان محمود عبداللطيف	سم المريض
القاهرة :	العنوان	45 Y	لجن
07/12/2021 11:11 :	تاريخ استلام العينة		أريخ اخذ العينة
14/12/2021 09:47 :	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	عنابة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER & PR: Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of 80 % of tumour cells
PR: moderate nuclear staining of 30 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67 : positive nuclear staining of about 35 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8 / 8)
PR: POSITIVE (SCORE 5 / 8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 35 % .
(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/أينان رمزي

Lab Director: د/ تريزا ماهر



Patient Name: Jihan Mahmoud Abd Al Latif Abd Al Maguid	Date : 25/02/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 5454/2021	Pat. ID: 12227

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - ACR b
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
25/02/2025 5:32 PM



Patient Name: Jihan Mahmoud Abd Al Latif Abd Al Maguid	Date : 16/02/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 5454/2021	Pat ID: 12227

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of left MRM.

I Chest:

Compared to 17/07/2022

- Status post left MRM showing no operative bed gross masses or sizable collections.
- Stable bilateral tiny pulmonary nodules some are calcified mostly of benign nature.
- Currently noted left upper lung lobe patchy consolidative opacities mostly representing post inflammatory sequel.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- Average sized liver showing homogeneous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non-contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- IUD is seen
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

- **Status post left MRM:**
- **Stable bilateral pulmonary nodules mostly of benign nature.**
- **No sizable hepatic deposits on non-contrast basis.**

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.